

Ballons ajustables ACT (pour les femmes)

Information pour le patient · Deux ballons ajustables qui soutiennent l'urètre en cas de fuites à l'effort **WARWIKI**

ACT (Adjustable Continence Therapy — thérapie de continence ajustable) est un implant de petite taille pour les femmes souffrant d'**incontinence urinaire d'effort** — fuites lors d'une toux, d'un rire, d'un effort ou d'un exercice. Deux petits ballons en silicone sont placés de chaque côté de l'urètre, près du col vésical, pour le soutenir et améliorer le contrôle. Comme son équivalent masculin (ProACT), les ballons peuvent être **ajustés en consultation** après l'intervention.

Comment ça fonctionne

Les fuites à l'effort surviennent quand le soutien et la pression de fermeture sous l'urètre sont insuffisants. Les deux ballons apportent un soutien doux et ajustable de part et d'autre de l'urètre pour qu'il reste fermé à l'effort — **sans** le comprimer complètement. Chaque ballon est relié à un petit **site d'injection** sous la peau des grandes lèvres, que votre chirurgien utilise pour ajuster le remplissage.

Est-ce adapté pour moi ?

- Option possible en cas d'**incontinence urinaire d'effort**, souvent envisagée lorsqu'une chirurgie antérieure n'a pas fonctionné ou que le muscle de fermeture est faible (ISD)
- Convient si vous souhaitez une solution peu invasive, **ajustable et réversible**
- **La disponibilité varie selon les pays** — le dispositif est utilisé dans des centres spécialisés et n'est pas proposé partout ; demandez à votre chirurgien s'il est accessible dans votre région
- Moins indiqué si les fuites sont surtout liées à un **prolapsus** ou à une **vessie hyperactive**

COMPRENDRE LES TERMES

Incontinence d'effort

Fuites urinaires lors d'une toux, d'un rire, d'un effort ou d'un exercice.

Col vésical

Zone de jonction entre la vessie et l'urètre (le canal d'évacuation).

Ballon

Petit ballon en silicone qui apporte un soutien doux et ajustable.

Site d'injection

Petite valve sous la peau des lèvres pour ajuster le ballon.

Titration

Réglage progressif du volume de sérum physiologique sur plusieurs consultations.

ISD

Insuffisance sphinctérienne intrinsèque — muscle de fermeture urétral affaibli.

EST-CE QUE ÇA FAIT MAL ? Les ballons sont mis en place lors d'une **courte intervention** sous anesthésie (générale, rachianesthésie ou locale avec sédation), généralement en **ambulatoire** par de petites ponctions près de l'orifice vaginal — sans grande incision. Vous pourrez ressentir des douleurs et un gonflement pendant quelques jours. Les ajustements ultérieurs en consultation sont rapides et ne nécessitent qu'une petite aiguille au niveau du site d'injection.

Comment ça se déroule

- 1 Sous anesthésie, guidé par **radioscopie ou échographie**, le chirurgien place un ballon de **chaque côté** de l'urètre près du col vésical, par de petites ponctions à côté de l'orifice vaginal.
- 2 Les tubes de connexion sont acheminés vers **deux sites d'injection** sous la peau des grandes lèvres.
- 3 Les ballons démarrent presque vides et laissés au repos le temps de la cicatrisation.

Ajustement du dispositif

- Quelques semaines plus tard, votre équipe ajoute un peu de **sérum physiologique** via le site d'injection **en consultation** — une simple piqûre, sans chirurgie.
- Ces ajustements sont répétés sur plusieurs visites jusqu'à obtenir un bon contrôle **sans difficulté à uriner**.
- Le volume peut être augmenté ou diminué à tout moment ; le dispositif peut être **retiré** si nécessaire.

Après

- Légères douleurs, gonflement ou ecchymoses pendant quelques jours ; évitez les efforts lourds et les activités intenses brièvement.
- Les fuites s'améliorent **progressivement** au fil des ajustements — pas toujours immédiatement.
- Informez tout futur chirurgien ou équipe d'imagerie de la présence de l'implant.

Appelez votre équipe soignante si vous avez :

- **Difficulté à uriner** ou incapacité à uriner (ballon peut-être trop rempli, ou gonflement)
- Fièvre, douleur croissante, rougeur ou écoulement au niveau d'un site (infection possible)
- Nouvelle gêne ou pertes vaginales, ou sang dans les urines (érosion possible)

TROIS CHOSES À RETENIR

1. ACT utilise deux ballons ajustables pour soutenir l'urètre et réduire les fuites à l'effort — peu invasif et réversible.
2. Il est mis en place par de petites ponctions, puis réglé en consultation sur plusieurs visites via un site d'injection labial.
3. Souvent proposé en cas de fuites récidivantes ou de sphincter faible ; la disponibilité varie selon les pays — appelez immédiatement si vous ne pouvez pas uriner ou présentez des signes d'infection.